

ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA

M^a Elena Aguirre Alastuey, Joaquín Llorente García, Cristina Sardiña González, Diana João Matías.

INTRODUCCIÓN

Definición

Alteración en el funcionamiento mental y cognitivo de carácter reversible secundaria a una insuficiencia hepatocelular aguda o crónica, o por la existencia de shunts portosistémicos.

Surge como consecuencia de una disfunción hepática aguda o crónica, que imposibilita la eliminación de las sustancias tóxicas y los productos nitrogenados procedentes del intestino, pasando a la circulación sistémica y posteriormente al sistema nervioso central.

Se presenta en el 30-45% de los pacientes con cirrosis hepática y en 10-50% con shunts portosistémicos.

Clasificación

Tipo I	EH asociada a insuficiencia hepática aguda.
Tipo II	EH en pacientes con shunts portosistémicos sin disfunción hepática.
Tipo III	EH asociada a cirrosis con HTP o shunts portosistémicos.

Clínica

Estadios clínicos según la escala de West Haven.

- Mínima. Resultados patológicos en test neuropsicológicos y psicométricos pero sin manifestaciones clínicas
- Estadio 1. Cambios en el comportamiento, irritabilidad, atención alterada, alteración ciclo sueño/vigilia. Incoordinación y temblor.
- Estadio 2. Letargia, somnolencia, desorientación temporal, (se entiende la conversación). Asterixis.
- Estadio 3. Estupor, marcada somnolencia o agitación psicomotriz (discurso incoherente). Hiperreflexia y rigidez.
- Estadio 4. Coma. Ausencia de respuesta al dolor.

DIAGNÓSTICO

Basado fundamentalmente en la clínica.

- **Anamnesis**
 - Se debe establecer el diagnóstico de sospecha en todo paciente con H^a previa de hepatopatía y presencia de síntomas neuropsiquiátricos. Debe descartarse presencia de focalidad neurológica.
 - Factores desencadenantes: hemorragias gastrointestinales, presencia de infecciones (PBE, ITU..), uso de diuréticos, estados de deshidratación(diarrea, vómitos), psicofármacos, exceso de ingesta proteica, hipoNa/K, estreñimiento, ect.
- **Exploración física**
 - Toma de constantes vitales
 - Evaluación neurológica (coma), respiratoria y cardiocirculatoria.
 - Exploración física general con especial atención a los estigmas de hepatopatía crónica (telangiectasias, ascitis, hepatoesplenomegalia, est) y neurológicos (descartar focalidad

nerológica).

- Tacto rectal: evidencia de sangrado
- **Pruebas de laboratorio**
 - Hemograma (signos de sangrado), bioquímica (datos de infección, ionograma y función renal) y coagulación.
 - Cultivos microbiológicos.
 - Determinación de tóxicos si sospecha.
 - Pruebas de imagen (foco infeccioso).
 - Paracentesis diagnóstica si presencia de ascitis (descartar PBE).
 - No se recomienda la medición de niveles de amoníaco de manera rutinaria
- **Diagnóstico diferencial**
 - Otras encefalopatías tóxicas, isquémicas, lesiones estructurales (focalidad neurológica, especialmente si ha presentado TCE asociado), trastornos neuropsiquiátricos.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

- **Medidas generales:**
 - Toma de constantes, anamnesis y exploración física, medir grado de encefalopatía.
 - Nutrición: Si se mantiene la vía oral, garantizar aporte de 1,2 g/kg/día (no indicada restricción proteica). Instaurar SNG /nutrición parenteral en caso de no tolerancia.
 - Hidratación y corrección de déficits vitamínicos (Tiamina).
 - Generalmente, los pacientes en EH en estadio 1 se pueden manejar de manera ambulatoria, y en estadio 3 y 4 precisarán ingreso hospitalario.
- **Corregir factor desencadenantes:**
 - Estabilización de hemorragia digestiva, suspender diuréticos y otros nefrotóxicos, instaurar antídotos si se sospecha intoxicación. Instaurar antibioterapia ante cuadro infeccioso.
- **Disminuir concentración de amoníaco:**
 - Lactulosa 30-50 ml vo cada 6-8 horas hasta conseguir 2-3 deposiciones blandas al día. Puede administrarse por enemas si no se tolera la vía oral, a dosis de 200cc de lactulosa en 700 ml.
 - Lactitol 10 g vo cada 6 horas.
 - Rifaximina 1200 mg / día vía oral. Si no hay mejoría a las 48 horas tras la administración de disacáridos, o estuviesen contraindicados.

En pacientes con encefalopatía recurrente, se mantendrá la dosis de lactulosa y/o rifaximina diariamente.

BIBLIOGRAFÍA

- Hepatic encephalopathy in chronic liver disease: 2014 Practice Guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases and the European Association for the Study of the Liver. Hepatology 2014; 60:715.
- Córdoba J, López-Hellín J, Planas M, et al. Normal protein diet for episodic hepatic encephalopathy: results of a randomized study. J Hepatol 2004; 41:38.
- Sharma P, Sharma BC. Disaccharides in the treatment of hepatic encephalopathy. Metab Brain Dis 2013; 28:313.